

03 - 03- Approche palliative (AUDIO) - Pr. Hachimi

(0:00 - 0:38)

Pour le SO-Module, si vous voulez, parce que SO-Module, ici, on a deux SO-Module, donc urgence et réanimation, et douleurs et soins palliatifs, avec une partie de la chirurgie plastique, professeur Benchamcha, qui a été mise avec nous dans SO-Module. Même si ça ne se figure pas pour la nomination du module. Donc, pour douleurs et soins palliatifs, on a au total six cours.

(0:40 - 1:03)

Donc, je ferai trois cours, professeur Ziedi, trois cours. D'accord? Donc, on a un cours aujourd'hui. Vendredi, ça sera professeur Ziedi, parce que j'ai un empêchement pour vendredi, et je terminerai avec vous la semaine prochaine.

(1:04 - 1:29)

On aura séance mardi et jeudi. Et professeur Ziedi continuera les deux cours qui restent. Donc, pour les trois cours, initialement, on a ce premier cours qu'on va parler de l'approche palliative ou du concept des soins palliatifs.

(1:30 - 2:46)

Deuxièmement, on aura tout ce qui concerne les soins palliatifs en matière de communication éthique, deuil, agonie. Et le dernier cours, ce sera à propos des symptômes et la prise en charge des symptômes et des complications des soins palliatifs. Donc, pour ce premier cours, qu'est-ce que vous avez comme notion à propos des soins palliatifs? C'est quoi? Ça concerne qui? Ça commence quand? On fait comment pour démarrer les soins palliatifs? Les structures qui existent? Oui.

(3:09 - 3:49)

Ça veut dire jusqu'à ce qu'on décide qu'il n'y a pas d'altération thérapeutique et on commence les soins palliatifs. On va voir ça aussi. Oui, effectivement.

(3:50 - 4:19)

Donc, ça doit commencer tôt au cours de la prise en charge des malades qui ont un pronostic réservé. Oui. Votre idée? Ça concerne quel genre de malade? Pardon? Les sujets âgés.

(4:19 - 4:28)

Oui. Donc, les sujets qui ont eu longtemps et qui sont fragiles. Oui.

(4:31 - 4:47)

Oui. Les cancéreux en phase finale. Les infirmités.

(4:48 - 5:16)

Les malades infirmes. En fait, ça enveloppe toute une liste. Donc, même par exemple, pour une tuberculose qui a une tuberculose résistante et qu'on ne trouve pas, qu'on n'est plus en mesure de le traiter.

(5:16 - 5:28)

Donc, il va s'altérer au fur et à mesure, tout doucement, progressivement. Et lui aussi, il sera candidat aux soins palliatifs. Les maladies HIV.

(5:30 - 5:39)

D'accord. Les maladies qui ont des complications, par exemple, un malade incisant cardiaque en stade final. Donc, il ne peut rien faire.

(5:39 - 5:56)

Il ne peut plus bouger. Donc, lui aussi, il peut être un candidat aux soins palliatifs. Ça se trouve où on peut les prendre en charge? Il y a un service.

(6:02 - 6:17)

Ça existe, mais pas en oncologie. Oui. Éventuellement, chez nous, dans la maison.

(6:22 - 6:50)

Même à domicile, pour les malades ou les patients qui ont un soutien familial. Donc, on peut avoir, on peut dédier une chambre et on peut prendre en charge un malade chez lui. Et on gère ça comment? Les soins palliatifs.

(6:51 - 7:16)

Les décisions, ça se fait comment? Pardon? Oui. Donc, la famille. Pardon? Oui.

(7:16 - 7:27)

Donc, l'équipe médicale. L'équipe. Donc, l'équipe soignante, si vous voulez.

(7:28 - 7:44)

Donc, la famille, l'équipe soignante, le patient lui-même. Il a le dernier mot à dire. Normalement, on n'est pas obligé à le traiter ou à lui administrer quoi que ce soit, s'il n'est pas d'accord.

(7:47 - 8:02)

Quatrième ou quatrième facteur qui intervient. Donc, la famille, le malade, l'équipe soignante et la nature de la maladie aussi. Il y a la nature de la maladie aussi.

(8:03 - 8:28)

On va voir tous et tout ça. Donc, avant de voir la définition proprement dite qui a été émise par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Il y a certains experts, certains volontaires qui ont travaillé en soins palliatifs et docteur Thérèse.

(8:28 - 8:40)

Donc, c'est une qui est décédée en 2004. Elle a dit les soins palliatifs, c'est tout ce qu'il reste à faire quand il n'y a plus rien à faire. C'est ça, son point de vue.

(8:41 - 8:56)

Et puis un autre, il a dit ajouter de la vie à chaque jour. Quand on ne peut plus ajouter des jours à la vie. Donc, il faut, c'est si on veut affiner ça, c'est en matière de qualité de vie.

(8:56 - 9:13)

Donc, assurer une meilleure qualité de vie durant les jours qui restent. Donc, les objectifs de cours, on va voir la définition, les principes de l'approche palliative. L'approche sur la démarche interdisciplinaire.

(9:13 - 9:41)

On va voir que c'est différent par rapport à la multidisciplinaire. Les patients qui sont candidats aux soins palliatifs, les phases de l'approche palliative ou des soins palliatifs et l'organisation des soins palliatifs. Donc, pour l'OMS, elle décrit les soins palliatifs comme les soins ou l'ensemble des soins dispensés aux personnes atteintes d'une maladie avec pronostic réservé.

(9:41 - 9:51)

Donc là, le mot clé, c'est pronostic réservé. Ça ne veut pas dire seulement les cancers ou certaines maladies. On va voir la liste.

(9:51 - 10:24)

Donc, comme objectif, principalement, c'est l'atténuation de la douleur, des autres symptômes, tous problèmes psychologiques, sociaux et spirituels. Donc, les soins palliatifs, ça englobe tout ce qui est médical, psychologique, social et spirituel. Donc, quatre facettes de la prise en charge, aux quatre volets de la prise en charge des soins palliatifs.

(10:24 - 11:03)

Donc, médical, psychologique, social et spirituel. Et on va le voir aussi au fur et à mesure, il n'y a pas les gens qu'on prend en charge pour des soins palliatifs, ce n'est pas que les patients. Il y a les patients, il y a la famille et il y a aussi l'équipe soignante parce qu'elle risque, avec le rythme avec lequel elle travaille cette équipe, elles peuvent être victimes de burn-out ou d'épuisement professionnel.

(11:03 - 11:33)

Donc, trois qui bénéficient des soins palliatifs. Donc, l'objectif, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est d'assurer ou d'obtenir la meilleure qualité de vie possible durant les jours qui restent. Les soins palliatifs sont organisés et dispensés grâce aux efforts et collaborations d'une équipe multidisciplinaire dans son organisation, dans son composition, mais elle est interdisciplinaire en matière de son travail.

(11:33 - 12:05)

On va voir la différence. L'historique, donc déjà pour Hippocrate, il décrit certaines qualités du médecin, parmi d'autres, soulager, guérir quand c'est possible, assister, accompagner toujours et témoigner d'une véritable compassion. Donc, ces principes-là, c'est parmi les piliers de la prise en charge des soins palliatifs.

(12:06 - 12:49)

La première unité de soins palliatifs ou le premier hôpital de soins palliatifs a été mis en place en 1907 à Londres. Toujours en historique, un psychiatre, madame Elisabeth Kubler-Ross, nous a décrit dans son livre Les derniers instants de vie, les étapes de réaction face à une maladie grave, à un malade. Après, en 1978, la première unité de soins palliatifs francophones et les soins palliatifs comme spécialité.

(12:49 - 13:02)

Ça a été reconnu en Angleterre en 1987 comme spécialité. Chez nous, pas encore. Ça fait partie de l'oncologie et de la radiothérapie.

(13:02 - 13:27)

En 1993, ils ont commencé à enseigner les soins palliatifs pour les infirmiers et les médecins. Elle a été reconnue chez eux comme spécialité en 2004. Et aux États-Unis, c'est jusqu'en 2007 où elle a été reconnue comme spécialité.

(13:31 - 13:42)

C'est juste pour information. Sur le plan épidémiologique, le besoin en soins palliatifs, ça augmente progressivement. On va voir certains chiffres.

(13:43 - 14:11)

Donc, vu le vieillissement de la population et vu la multiplication ou l'augmentation de la fréquence des maladies non transmissibles et transmissibles. Et quand on instaure des soins palliatifs, ça permet, durant le parcours de soins d'un malade, il permet de réduire le nombre d'hospitalisations inutiles et de réduire le recours aux services de santé. Donc, ça réduit la prise en charge.

(14:15 - 14:42)

Là, c'est un rapport de 2021 d'une organisation de l'Alliance de l'Etat. Donc, on a 57 millions de patients durant l'année 2021 qui ont nécessité des soins palliatifs. 57 millions à travers le monde.

(14:46 - 15:21)

Parmi ces 57 millions, 7% ce sont des enfants. 7% ce sont des enfants. 12%, 12% seulement qui ont des soins palliatifs du moins les deux fois.

(15:21 - 15:49)

parce qu'ils ont bel et bien reçu des soins palliatifs, pas juste une prise en charge fragmentée. Parmi ces 57 millions, 25% se sont dus à des maladies transmissibles type VIH, tuberculose et dernièrement la COVID. 45% sont en fin de vie, à peu près la moitié.

(15:52 - 16:51)

Et 64% des pays où il y a ces 57 millions, ils ont des ressources limitées en matière de soins palliatifs. 76% se sont au niveau, à peu près trois quarts, 76, c'est des pays pauvres ou des pays en voie de développement. 69% des maladies non transmissibles, donc les cancers, les démences, les AVC, les insuffisants cardiaques, hépatiques, rénales, les insuffisants respiratoires et les malades, on le connaît très bien dans notre contexte, les malades qui ont des traumatismes crâniens ou des traumatismes graves, ils peuvent garder des séquelles même si c'est sans jeûne.

(16:52 - 17:15)

83% n'ont pas accès au morphine pour la douleur. Et ce taux-là, il va augmenter de 87% en 2060. Donc on aura encore plus de malades.

(17:17 - 17:41)

Au fur et à mesure, on a des malades qui s'ajoutent. Les caractéristiques des soins palliatifs, il

faut considérer le malade comme un être vivant, mais pas comme quand il est à l'hôpital, comme un numéro de dossier ou un numéro de chambre. Ce n'est pas le malade BOX5, mais c'est le malade FLEM.

(17:43 - 18:06)

Il faut considérer la mort comme un processus naturel, surtout dans notre contexte, on n'a pas beaucoup de problèmes de ce côté. Procurer le soulagement de la douleur et des autres symptômes, c'est parmi ses caractéristiques. Les soins palliatifs, ils ne servent ni à repousser, ni à accélérer la mort.

(18:06 - 18:14)

C'est juste d'améliorer la qualité de vie. Intégrer les aspects psychologiques et spirituels. On l'a déjà dit.

(18:14 - 18:41)

Aider les patients à vivre le plus activement possible. Aider les familles à tenir au cours de la maladie et au cours du deuil et dans une approche interdisciplinaire. Il doit être appliqué le plus tôt possible dès la découverte du diagnostic, mais pas jusqu'à ce qu'on n'ait rien à proposer comme traitement curatif.

(18:41 - 19:17)

Il doit commencer depuis l'annonce du diagnostic. Concernant le concept d'interdisciplinarité, le travail interdisciplinaire, on a une équipe et on a au centre le malade. Donc, analyse et synthèse de plusieurs spécialités, de plusieurs praticiens qui vont associer leurs compétences afin d'harmoniser les interventions vers un objectif commun qui est le malade.

(19:20 - 19:57)

En concertation, en équipe, en multidisciplinarité, chacun fait son travail indépendamment de l'autre et chacun conserve ses concepts, son traitement. De ce fait, parfois on a des malades qui reçoivent plusieurs traitements et ces traitements parfois sont doubles ou des médicaments qui font la même chose et qui sont prescrits par différents praticiens. Donc là, le concept le plus utilisé en soins palliatifs, c'est le concept interdisciplinaire.

(20:00 - 20:54)

Les principes des soins palliatifs, donc on a dit ça concerne le patient, la famille et l'équipe soignante. Pour le patient, il faut préserver sa dignité, respecter son libre choix, on ne peut pas l'obliger à lui dire quoi que ce soit ou à lui administrer quoi que ce soit sans aval, préserver son confort, prendre en charge sa souffrance globale, comme on a dit tout à l'heure, souffrance

médicale, psychologique, spirituelle et sociale. Pour la famille, la communication et la formation en continuent pour les intégrer dans les prises en charge, pour les intégrer dans les soins et pour diminuer de se sentir coupable au cours du dé.

(20:57 - 21:35)

Donc on les implique dans la prise en charge et la prise des décisions, assurer leur accompagnement et leur soutien psychologique, préparer et prendre en charge leur deuil. Pour l'équipe soignante, il faut travailler en interdisciplinarité pour que ce soit harmonieux, coordonner et assurer la continuité des soins. La continuité des soins, c'est si la famille n'a pas de moyens, par exemple, et s'il décide de prendre en charge où il n'y a pas de structure où on peut hospitaliser, le malade sera pris en charge chez lui.

(21:36 - 21:58)

Donc la famille doit être incriminée dans la prise en charge et dans la surveillance du malade. Préserver l'équipe soignante de l'épuisement professionnel. Le travail en matière de soins palliatifs n'est pas facile, surtout avec des malades fragiles qui ont un pronostic qui est réservé.

(22:00 - 22:29)

Donc il y a trois types d'évolution chez les malades en soins palliatifs, ou trois trajectoires si vous voulez. Donc on a le premier trajectoire ou la première évolution, c'est le déclin rapide, il est progressif mais il est rapide jusqu'au décès. C'est essentiellement les malades cancéreux où progressivement leur état s'altère.

(22:30 - 22:51)

Pour le deuxième type, c'est les malades qui ont des maladies métaboliques qui ont des défaillances cardiopulmonaires. Ils ont une évolution progressive, certes, mais elles sont avec des décompensations, avec des récupérations, mais des récupérations moins bonnes qu'avant. Donc il y a une altération avec des déclins.

(22:53 - 23:17)

Et le troisième type, c'est les malades très âgés, les malades déments. Donc on a un déclin qui est lent, qui est graduel, et qui est prolongé dans le temps jusqu'au décès. Donc on en a parlé tout à l'heure, le moment où on peut démarrer les soins palliatifs.

(23:19 - 23:45)

Donc là, avant, on dit que les soins palliatifs, on les commence jusqu'à ce qu'on n'a plus de traitement curatif. Là, on commence les soins palliatifs jusqu'au décès, jusqu'au deuil. Alors que de plus en plus, et depuis quelques années, les soins, on dit soins palliatifs ou soins de support.

(23:46 - 24:02)

C'est le même concept. Normalement, on devrait les démarrer depuis l'annonce du diagnostic grave. Et ça prend de l'ampleur jusqu'à ce qu'on décide qu'il n'y a pas de traitement curatif.

(24:02 - 24:53)

Et là, les soins palliatifs, ils prennent toute l'ampleur dans la prise en charge du malade. Parce qu'on n'est pas sûr que ce traitement curatif va être efficace. Et ce genre de malade, c'est un pourcentage qui est réduit, qui a une évolution favorable sur une longue période d'année.

(24:55 - 25:27)

Mais la plupart du temps, ou une grande partie de ce genre de malade, ils font des récurrences, d'accord ? Ou ils décompensent, ils restent pendant un moment sous traitement immunosuppresseur. Et ils vont faire des décompensations, des infections, des décompensations de leurs maladies chroniques, et ainsi de suite. Donc on n'est pas sûr, oui, c'est curatif à ce moment-là, mais on n'est pas sûr que ça sera efficace et qu'il va être guéri complètement.

(25:28 - 25:49)

Quand il va être guéri complètement, c'est bon, tant mieux. Mais si on ne le guérit pas complètement, on va continuer, d'accord ? Donc là, c'est à peu près la même chose, juste ce qui s'ajoute à cette plaque, c'est qu'on a des soins spécifiques, si vous voulez, curatifs. Les soins palliatifs commencent.

(25:50 - 26:14)

La prise en charge de l'entourage, ça commence aussi depuis l'annonce du diagnostic. Et les soins, on a la phase curative, on a la phase palliative, et la phase palliative, on a trois phases. Ou trois stades, si vous voulez, en phase palliative, on a les soins palliatifs initiaux avancés ou terminés.

(26:18 - 26:33)

Pour la phase curative, l'objectif, c'est la guérison. Mais pour la phase palliative, précoce ou initiale, l'objectif, c'est l'amélioration. L'objectif principal, c'est l'amélioration de la qualité de vie.

(26:34 - 26:53)

Du malade et de son entourage. Cependant, on peut avoir recours à certaines thérapeutiques pour améliorer cette qualité de vie. Par exemple, un malade en soins palliatifs qui fait, par exemple, un syndrome CAV supérieur.

(26:54 - 27:18)

Donc là, on ne peut pas le laisser comme ça. Donc, on peut parfois être amené à pratiquer une chimiothérapie, parfois une radiothérapie, ou parfois une intervention. Devant un syndrome CAV, on peut mettre, par exemple, une prothèse endovasculaire pour diminuer la pression et pour améliorer le malade.

(27:19 - 27:40)

Donc, on peut avoir recours à certaines thérapeutiques pour améliorer cette qualité de vie. En phase avancée des soins palliatifs, c'est le contrôle du symptôme. Donc là, il y a une certaine régression dans notre prise en charge.

(27:41 - 28:02)

Donc, le traitement curatif, il sera parfois même nuisible pour le malade. Donc, c'est l'amélioration du symptôme ou le contrôle du symptôme pour un meilleur confort. En phase terminale, les symptômes se multiplient, donc on les traite séparément.

(28:03 - 28:35)

À certains moments, il ne reste que, par exemple, le traitement de la douleur et les soins de base, les soins de bouche, les soins de corps, et on arrête tout le thérapeutique. Donc, comme on a des soins palliatifs de premier recours et les soins palliatifs spécialisés. De premier recours, c'est l'évaluation.

(28:36 - 28:49)

Ça sert à évaluer les besoins individuels du malade. Communication pour prendre des décisions, soit avec le malade, soit avec la famille. Le traitement des symptômes existants ou potentiels.

(28:52 - 29:15)

Parfois, il est préférable d'anticiper un traitement. Par exemple, au cours d'un traitement morphinique, par exemple, on sait que parmi les effets secondaires les plus importants, c'est la constipation, par exemple. Donc là, quand on prescrit les morphiniques, il faut associer un traitement à l'additif depuis le début.

(29:15 - 29:30)

Donc là, on anticipe. Information de la personne pour prendre des décisions. Donc, la prise de décision, il faut que ce soit en concertation et jamais une prise de décision illatérale.

(29:30 - 29:57)

Donc, équipe médicale, la famille et le malade. Planification préalable du lieu de séjour possible. Si c'est à domicile, si c'est à une maison de retraite, si c'est dans le HSA, si c'est chez nous, c'est

pas comme en Europe, il y a des établissements de santé de cours, de moyens et de long séjour.

(29:58 - 30:16)

Donc, ils sont bien organisés que nous. Et on informe le malade sur les unités ou sur les structures où il y a, où on peut produire des soins palliatifs. Pour les soins spécialisés, c'est l'atténuation des symptômes.

(30:17 - 30:42)

Lourd, on va le voir au cours du troisième cours. La prise de décision difficile par une équipe interprofessionnelle. Parfois, c'est un peu difficile de gérer l'orientation du patient en cas de la détérioration de son état et le soutien à la famille durant toute la prise en charge avec une bonne information, communication.

(30:48 - 31:28)

Les soins palliatifs, c'est comme dans de nombreux pays, il y a certains freins, il y a certaines difficultés, d'accord, qui freinent ou qui entravent l'évolution des soins palliatifs. Donc là, l'OMS, il a décrit quatre problèmes essentiels. Premièrement, la méconnaissance des décideurs ou des responsables politiques des professionnels de la santé et du grand public, d'accord.

(31:29 - 32:08)

Donc, par exemple, pour les responsables politiques, jusqu'à maintenant, on n'a pas de loi ou on n'a pas de texte qui gère les soins palliatifs, alors que dans les autres pays, ils ont des lois bien définies avec des textes qui reçoivent les soins palliatifs, où, quand, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire et ainsi de suite. Professionnels de la santé, il y a plusieurs professionnels de la santé qui ne sont pas au courant de ce genre de soins. Les obstacles culturels et sociaux, d'accord.

(32:08 - 32:47)

Par exemple, je dis n'importe quoi, mais parfois, c'est la croyance à propos de comment mourir. Il y a des gens qui disent juste des idées. Donc, si je ne souffre pas, il y a des gens qui disent alors que non.

(32:48 - 33:13)

Oui, déjà, les symptômes et la prise en charge, on doit les accepter, d'accord. Et les idées erronées à propos des soins palliatifs. Il y a des gens qui disent c'est pour les cancers, ce n'est pas pour les autres.

(33:14 - 33:30)

Des idées fausses à propos de la dépendance aux épouides. Si le malade initie les épouides, il faut les prescrire. Bien sûr, en respectant les paliers de l'OMS, parce que si c'est une maladie chronique, il va nécessiter un traitement au long coup.

(33:30 - 33:46)

Quand on a besoin des épouides, il faut les introduire. Parce que là, on a une indication, on en a besoin. Donc, ce n'est pas comme un malade qui n'a pas besoin, il va les administrer.

(33:47 - 34:11)

Il y a un risque de dépendance, mais quand le malade, il en a besoin, donc il n'y a pas de risque de dépendance. Les actions qui ont été émises par l'OMS pour améliorer le développement des soins palliatifs, il y en a six points. Premièrement, intégrer les soins palliatifs dans les programmes de santé ou les programmes de lutte contre les maladies.

(34:12 - 34:26)

Par exemple, chez nous, on a un programme de lutte contre la tuberculose. Est-ce qu'il y a une rubrique où on parle des soins palliatifs? Non. Il y a un guide, par exemple, pour les AVC.

(34:27 - 34:33)

On n'en parle plus. Donc, il y a plusieurs programmes où certains malades peuvent évoluer en soins palliatifs. On n'en parle pas.

(34:34 - 34:48)

Élaborer des lois ou des lignes directrices pour l'intégration des soins palliatifs dans des groupes de maladies et au niveau des soins. On va voir les structures. Il y a des structures dans notre contexte qui sont très limitées.

(34:48 - 35:02)

Et on a beaucoup de malades qui nécessitent des soins palliatifs. En réanimation, on reçoit pas mal de malades. Et parfois, la famille, quand le malade s'améliore, elle refuse de le faire sortir.

(35:03 - 35:39)

Parce qu'il n'y a pas assez de structures pour eux. Aider les états membres, c'est-à-dire les états membres des Nations unies au sein de l'OMS à développer les médicaments ou l'accès aux médicaments en améliorant la réglementation et la délivrance. Pour les opïdes, vous savez, la prescription, vous l'avez vu en pharmacologie, il y a une prescription spéciale avec des ordonnances et ainsi de suite, carnet de souche et pour la traçabilité du traitement.

(35:40 - 36:08)

Promouvoir l'accès pour les enfants en collaboration avec l'UNICEF. Il y a des enfants qui nécessitent des malades, des enfants qui naissent avec une infirmité psychomotrice, par exemple, qui ont une souffrance néo-intacte et qui évoluent vers une infirmité et ainsi des soins palliatifs depuis leur enfance. Encourager la disposition des sources suffisantes et des programmes de soins palliatifs.

(36:08 - 36:41)

Et encourager la recherche dans ce domaine pour améliorer la prise en charge. Au Maroc, ça a été dit qu'il y a un service de soins palliatifs et ce n'est pas en oncologie. Qui a une idée, ça se trouve ? On ne l'appelle pas un service, mais c'est une unité.

(36:41 - 36:56)

On l'appelle unité de soins palliatifs. Qui la connaît ? On l'a au CHU. C'est Abna Taufey qui la connaît.

(37:02 - 37:13)

Le bâtiment où il y a le laboratoire en bas, l'ancien bâtiment, c'est au troisième étage. On a une unité de soins palliatifs. On va voir sa composition.

(37:16 - 37:56)

Déjà, il y a plusieurs écrits concernant les soins palliatifs, les journaux, les Human Rights Watch. Il y a plusieurs écrits concernant, ce n'est pas la dégradation, mais le sous-développement des soins palliatifs dans notre pays. Il y a eu après l'installation de cette unité de soins palliatifs, à l'hôpital Abna Taufey, il y a aussi un DU, un diplôme universitaire à la faculté d'Arabat, pour ça.

(37:57 - 38:47)

Et avec la mise en place de la fondation LNSMA, qui a bien fait avancer les choses en matière de prise en charge des malades cancéreux et des soins palliatifs, il y avait un guide en 2018 pour les soins palliatifs, mais c'est juste pour les malades cancéreux, pas pour les autres malades. Et d'ailleurs, cette unité qui est Abna Taufey, c'est pour les malades cancéreux, mais on l'utilise pour les autres malades. Donc, normalement, il y a une unité de soins palliatifs dont c'était prévu que ce soit dans chaque région où il y a un centre d'oncologie, il doit y avoir une unité de soins palliatifs.

(38:48 - 39:29)

Mais jusqu'à maintenant, on a une à Rabat, Kaza, Fes-Meknes, l'Oriental, Marrakech et Tangier-

Titou. Donc, chez nous, à Marrakech, il y a une unité de soins palliatifs où il y a neuf chambres doubles, donc ça fait 18 lits, avec un hôpital de jour avec trois fauteuils et le personnel, on a deux médecins et huit infirmiers. On peut hospitaliser le malade pour courte durée ou en hôpital de jour, ou parfois juste pour une consultation, soit pour le malade, soit pour sa famille.

(39:30 - 40:19)

Et chaque unité, on va le voir, dans l'organisation du soins palliatifs, avec chaque unité de soins palliatifs, il y a une équipe mobile de soins palliatifs qui se déplacent vers les malades, qui ne peuvent pas se déplacer à l'hôpital, où il y a un médecin, une infirmière et un psychologue. La partie des soins palliatifs dans le programme national de lutte contre le cancer, donc le premier programme national a été mis en place en 2010, et ça a pris dix ans. Donc il y avait quatre axes et 78 mesures au total avec ces quatre axes.

(40:19 - 40:41)

Le quatrième axe, il concernait les soins palliatifs et l'accompagnement psychosocial. Dans ce quatrième axe, il y avait quatre actions et 13 mesures. Donc les actions, si vous voulez, c'est développer la prise en charge de la douleur.

(40:41 - 41:08)

Donc prise en charge de la douleur, l'accompagnement familial et social, assurer le développement et l'extension des soins palliatifs et le développement de la recherche. Et on a des objectifs ou des mesures à développer. Oui, oui, jusqu'au décès.

(41:12 - 41:38)

C'est en fonction de l'évolution, c'est en fonction des décompensations aux suites des maladies intercurrentes qu'il fait. Par exemple, s'il y a juste des symptômes qui sont en rapport avec la maladie, ça ne nécessite pas d'hospitalisation. Mais si tu me dis que le malade, par exemple, il fait une infection sévère, ça peut nécessiter une hospitalisation.

(41:38 - 42:07)

Donc là, ça vient du rôle, soit de l'unité de soins palliatifs là où le malade peut consulter, ou l'équipe mobile qui va se déplacer vers le malade pour évaluer son état et est-ce qu'il nécessite l'hospitalisation ou pas. Oui. Et après ce programme, il a pris fin en 2019.

(42:08 - 42:26)

Donc il y avait à nouveau, qui a démarré en 2020 et qui terminera en 2021. Son objectif principal, c'est la prise en charge à 100% des malades cancéreux qu'il prend qui ont besoin des soins palliatifs. C'est l'objectif principal.

(42:29 - 42:43)

Après, il y a la partie où ça concerne les soins palliatifs. Il y a cinq actions. Premièrement, proposer des textes.

(42:43 - 43:01)

Donc il faut rédiger des lois, des textes, pour organiser et pour gérer les soins palliatifs. Donc proposer des textes réglementaires des soins palliatifs conformément à la bioéthique. La deuxième, renforcer les aspects organisatifs et normatifs des soins palliatifs.

(43:01 - 43:26)

Donc comment on va organiser, comment on va gérer. Troisièmement, renforcer la prise en charge sociale et développer l'approche communautaire. Donc c'est-à-dire sur le plan social, un malade qui ne peut plus travailler et probablement il n'a aucune ressource, aucune source, si vous voulez, pour qu'il puisse vivre.

(43:27 - 43:47)

Donc là, devient le côté de la prise en charge sociale. Donc là, il faut intervenir les ONG et les organisations et la société civile. Après, c'est généraliser la prise en charge de la douleur.

(43:47 - 44:11)

Donc d'ici 2029, tous les conservateurs doivent avoir un traitement antalgique adéquat. La cinquième action, c'est développer la recherche et la formation continue des ressources humaines qui sont dédiées aux soins palliatifs. Donc à partir de ces cinq actions, il y a des résultats attendus pour ce programme.

(44:12 - 45:21)

Donc 100% de couverture du territoire national des équipes mobiles, prise en charge 100% des malades qui nécessitent des soins palliatifs et multiplication de la consommation des antalgiques, essentiellement les morphiniques, par deux pour améliorer le confort des malades. Donc on a dit, c'est les malades qui sont âgés qui sont candidats aux soins palliatifs, c'est les malades qui ont des maladies incurables, des malades qui ont des maladies non transmissibles et qui sont, par exemple, insuffisants cardiaques ou insuffisants respiratoires à un stade avancé, ils peuvent nécessiter aussi des soins palliatifs. Donc les patients atteints de maladies graves, en âge avancé, les malades cancéreux, on n'en parle plus, donc ils font partie de cette catégorie, et les personnes dans la vie profonde dans le grand âge.

(45:22 - 46:42)

Un patient qui est âgé de 120, 130, il va vivre, mais son état s'altère au fur et à mesure, donc lui aussi, il nécessite des soins palliatifs. Et les proches des patients, donc la famille aussi, ils sont intégrés dans la prise en charge des soins palliatifs. Donc là, c'est une étude de l'OMS, donc ils ont fait un recensement des maladies, si je me rappelle en 2018, donc les maladies cardiovasculaires en premier, c'est pas les cancéreux, 38,5%, les maladies cancéreuses, 34%, les insuffisants respirateurs, les maladies respiratoires chroniques, 10%, les VIH, à peu près 6%, les diabétiques au stade final, parce qu'il y a les diabétiques, ils font des complications, ils font de la cécité, ils font une insuffisance rénale chronique dialysée, avec l'aneuropathie, ils ont des membres amputés, donc eux aussi ils nécessitent des soins palliatifs.

(46:42 - 47:32)

Et les autres maladies, les insuffisants rénaux, les maladies hépatiques chroniques, les psychotiques par exemple, les maladies de surcharge, les maladies neurologiques, les démences, sclérose en plaques, les maladies de Parkinson, les polarités thromatoïdes, ils ont tous les membres qui sont déformés, qui ne peuvent plus faire quoi que ce soit, les maladies congénitales, et la tuberculose pharmacorésistante. On a de plus en plus de malades qui ont des bécares qui sont multirésistants, et on ne peut plus les traiter, et ça demande certains molécules, et ça demande beaucoup de temps. Donc eux aussi, ils sont intégrés aux soins palliatifs.

(47:35 - 48:20)

Pour les pays qui ont des lois, qui ont des textes, donc par exemple là, c'est une fiche de l'Angleterre, elle a été traduite. Donc là, il y a une fiche avec laquelle il est valu le besoin en soins palliatifs et la nature de la maladie. Les lieux, comme on a dit tout à l'heure, ça peut être à domicile, ça peut être au sein des unités de soins palliatifs, ça peut être dans des établissements de santé, ça peut être des structures d'aide aux sujets âgés, comme chez nous.

(48:25 - 49:12)

Pour le déroulement, si vous vous rappelez, on a dit qu'il y a quatre intervenants ou quatre composantes dans la prise en charge et dans la prise de décision et dans la gestion des soins palliatifs. Donc on a le malade avec son expérience, ses symptômes, sa souffrance, ses désirs et ses objectifs. Qu'est-ce qu'il veut des soins palliatifs? On va voir au deuxième cours que quand le malade refuse qu'on lui administre un traitement, il ne faut pas l'administrer.

(49:13 - 49:27)

Donc il faut avoir tout son accord pour administrer un traitement vis-à-vis de la famille. Il y a aussi la maladie, son stade, sa nature, les options thérapeutiques. Et il y a l'équipe soignante et la famille.

(49:29 - 49:57)

Donc là, il y a une formulation des objectifs. Bien sûr, ces objectifs qu'il faut prendre, il faut que ce soit évalué en fonction du bénéfice-risque, selon le désir du malade et selon la compatibilité avec les objectifs qu'on a instaurés ou les objectifs que le malade veut. Donc c'est ses objectifs à lui.

(49:58 - 50:24)

Donc là, reprenez que pour la prise en charge ou pour la prise de décision en matière de soins palliatifs, c'est la maladie, le malade, l'équipe soignante et la famille. Par exemple, en France, il y a une loi qui a été votée en 2005. Elle s'appelle la loi Leonetti.

(50:24 - 50:51)

Leonetti, c'est un débuté qui était le responsable de cette loi. Donc c'est détaillé, c'est avec des objectifs, les malades, comment faire, tout ça englobe tous les aspects des soins palliatifs. Cette loi, elle englobe quatre principes, quatre grands principes.

(50:53 - 51:17)

Le premier principe, c'est le refus où il ne faut pas avoir une obstination des raisons là. On va voir la définition après. C'est qu'il ne faut pas, si on est au courant du pronostic, il ne faut pas s'acharner à traiter.

(51:19 - 51:40)

D'accord ? Donc il y a des limites pour ne pas gaspiller les moyens médicaux. Deuxième, la prise en compte de la volonté de la personne et la reconnaissance de son autonomie. On ne peut pas l'obliger ni à prendre une décision ni à recevoir un traitement.

(51:41 - 51:56)

Devoir de tout mettre en œuvre pour éviter la douleur. C'est un volet très important, la prise en charge de la douleur. La collegialité, la concertation de l'équipe et la transparence des décisions.

(51:57 - 52:23)

Donc là, comme on a dit tout à l'heure, c'est l'équipe interdisciplinaire ou le travail interdisciplinaire pour avoir un objectif commun et pour une prise en charge harmonieuse. Les structures, en France toujours, ils ont quatre structures de soins palliatifs. Premièrement, c'est des unités de soins palliatifs.

(52:25 - 52:47)

Il y a des équipes qui sont rattachées à ces unités de soins palliatifs. Et il y a des lits. Donc, ces trois premières unités, normalement, pour la prise en charge de soins palliatifs chez les

conseillers, on a la même chose.

(52:48 - 53:16)

Pour les lits identifiés de soins palliatifs, ce sont des lits qu'on peut désigner ou qu'on peut avoir dans un système. Donc, il y a un service où il y a la prise en charge d'autres malades. Par exemple, dans un centre hospitalier, par exemple, provincial ou régional, on peut, par exemple, le dédier au service de médecine.

(53:17 - 53:39)

Trois ou quatre lits qui sont dédiés pour les soins palliatifs. Dans un service de médecine interne, dans un service de gériatrie. Donc, il y a un service qui a un autre objectif, mais on précise trois ou quatre lits qui sont identifiés pour les soins palliatifs.

(53:40 - 54:00)

Et ces structures-là, elles sont organisées en réseau. Donc, il y a une communication entre eux pour la prise en charge des malades et pour partager l'information concernant les malades en soins palliatifs. Chez nous, on a les unités de soins palliatifs.

(54:01 - 54:21)

On l'a dit, dans chaque région, on a une unité de soins palliatifs. Normalement, il faut identifier des lits pour les soins palliatifs dans certains hôpitaux, essentiellement les CHP et les CHR. Et l'équipe mobile est rattachée à chaque unité de soins palliatifs.

(54:22 - 55:11)

Et il y a aussi, mais à ma connaissance, ce n'est pas effectif, c'est que ça a été... On va l'expliquer après. Pour les zones éloignées, donc au niveau des centres de santé, on doit former un médecin et une infirmière en soins palliatifs pour prendre en charge les malades qui vivent à distance ou qui vivent dans des zones enclavées et qui ne peuvent pas arriver aux unités de soins palliatifs. Donc, pour les unités de soins palliatifs, donc toujours chez nous, ce qui a été prévu d'ailleurs, ce sont des unités qui sont rattachées aux centres régionaux d'oncologie.

(55:14 - 55:35)

Il y a des lits, il y a l'hôpital du jour, il y a une consultation externe. Donc, c'est tous les moyens qui sont possibles. Soit le malade vient en consultation avec une ordonnance, soit le malade nécessite d'administrer un traitement, on l'hospitalise le matin, il reçoit son traitement, on le fait sortir l'après-midi, ou un malade qui nécessite une hospitalisation de deux ou trois jours.

(55:39 - 56:04)

Une triple mission, en théorie, donc c'est les soins pour les malades, la formation d'autres personnels pour les soins palliatifs, pour travailler dans d'autres structures, et la recherche. Donc, le cible, c'est les malades qui sont compliqués et qui ont des symptômes non contrôlés. Donc, ça nécessite une intervention médicale et infirmière.

(56:04 - 56:24)

Donc, ça sert à accompagner les malades et leurs proches qui présentent des souffrances morales, sociales ou médicales. Donc, c'est une structure de référence, de recours et de coordination pour les équipes mobiles. Donc, l'équipe mobile est rattachée à cette unité.

(56:24 - 56:54)

Et les établissements qui disposent des lits identifient parfois les soins palliatifs parce qu'il n'y a pas de spécialistes. Parfois, on peut adresser le malade vers un lit identifié de soins palliatifs, par exemple, pour recevoir un traitement ou pour avoir un avis spécialisé. Donc, c'est environ cinq à dix lits et ça accueille les malades pour une courte durée.

(56:54 - 57:12)

C'est pas pour de longues durées. Après, pour les lits identifiés, donc on a dit soit au CHP ou au CHR, il y a des lits identifiés pour les soins palliatifs. Ça assure la prise en charge de proximité, si, par exemple, j'ai dit n'importe quoi.

(57:12 - 57:52)

Donc, l'utilisation palliatif à Marrakech, donc on peut avoir des lits identifiés à par exemple. Donc, on a des lits identifiés et les malades peuvent être hospitalisés là-bas pour qu'ils soient pris en charge. Donc, on a une équipe médicale et paramédicale pour la prise en charge de ce genre de malades et pour les malades qui ont besoin d'un avis spécialisé ou des malades qui sont visités par l'équipe mobile et qui nécessitent une hospitalisation.

(57:52 - 58:08)

Et la structure la plus proche, c'est les lits identifiés. Assurer les côtés d'accompagnement. Donc, on a un médecin, un référent, que ce soit un médecin ou un infirmier dans cette structure.

(58:08 - 58:22)

Ça prend en charge les malades et leurs familles. Et bien sûr, ça coordonne avec les unités et l'équipe mobile. Pour l'équipe mobile, elle est rattachée à l'unité de soins palliatifs.

(58:23 - 58:33)

Elle prend en charge à domicile les patients et leurs proches. Leur rôle, c'est le rôle de conseil et

du soutien. Réaliser des enquêtes sociales pour voir le niveau de vie.

(58:34 - 58:53)

Assurer le suivi des malades parfois à travers des appels téléphoniques. Coordonner l'activité des différentes entités de soins palliatifs avec les lits, avec les unités. Et ça fonctionne 5 jours sur 7 avec un médecin qui coordonne, avec un infirmier.

(58:53 - 59:06)

Et on peut ajouter d'autres profils professionnels pour la prise en charge. Ça peut être un psychologue, un assistant social, un kiné, un diététicien. Et elle doit bénéficier, bien sûr, cette équipe mobile d'une formation continue.

(59:08 - 59:28)

Pour les centres de santé, c'est assurer la prise en charge des malades dans des zones éloignées. Les centres de santé sont désignés par province au niveau des zones éloignées. Et on a un infirmier et un médecin qui sont formés pour accompagner les malades en phase terminale.

(59:32 - 1:00:33)

Ces malades doivent être prêts en charge à côté du centre de santé, les ONG et les autorités locales pour faciliter leur transport et leur déplacement. Donc, l'équipe de soins palliatifs, comme on va les détailler, on l'a dit au niveau de l'équipe mobile et au niveau des unités de soins palliatifs. Donc, il y a un médecin qui assure le dérèglement, qui est responsable.

Il coordonne et supervise les activités de cette équipe. Un infirmier pour la mise en route, la mise en oeuvre des soins. Un travailleur social.

C'est quelqu'un, c'est essentiellement les volontaires qui occupent ce poste. Il y a des kinés, des diététiciens pour pallier aux problèmes alimentaires ou de nutrition. Un psychologue.

(1:00:36 - 1:01:19)

Parfois, on a besoin de soi-disant un religieux. Parfois, il y a des malades en phase finale qui demanderont de voir un frère ou quelqu'un d'autre pour l'assister. Et des autres compétences en fonction du besoin.

Donc, cette équipe n'est pas exhaustive. Donc, on peut y intégrer tous les profils possibles qu'on a besoin au sein de l'équipe de soins palliatifs. Donc, l'organisation, les malades se déplacent d'une structure à une autre et ils peuvent revenir vers la première structure.

(1:01:20 - 1:01:50)

Donc, l'équipe, les centres de santé ou les équipes au niveau des provinces, elles peuvent se déplacer vers un CHP ou un CHR. Puis, ils peuvent se déplacer pour quelque chose de spécialisé au CHU. Et quand l'objectif est atteint, on peut les réhospitaliser dans ces structures et ils peuvent à la fin revenir chez eux.

(1:01:53 - 1:02:18)

La base des soins palliatifs, c'est pas exhaustif. C'est essentiellement la prise en charge de la douleur, les soins de bouche, la prévention et le traitement des escarpes, les soins de corps et la prévention des raideurs et des contractures musculaires. C'est les mesures de base des soins palliatifs.

(1:02:19 - 1:02:50)

Et ça peut ajouter la prise en charge d'autres symptômes qui peuvent survenir au cours de l'évolution de ce genre de maladie. Les aspects de prise en charge, comme on l'a dit tout à l'heure, on a les aspects médicaux, sociaux, psychologiques et spirituels. Donc, les aspects médicaux, le traitement de la douleur, des symptômes, des complications.

(1:02:51 - 1:03:14)

Les aspects sociaux, il faut évaluer ce malade. Comme on a dit tout à l'heure, il n'a plus de source et parfois il n'a plus de membre de famille. Donc, il y a des ONG, il y a des associations au sein de la société civile qui prend en charge ce genre de malade.

(1:03:15 - 1:03:49)

Pour l'aspect psychologique, c'est très important parce que ce genre de malade a une détresse psychologique et il développe, on va le voir au cours du deuxième cours, il y a des mécanismes de défense face à certains symptômes et face aux complications et face aux symptômes palliatifs. Ils ont des moyens de défense. Et le retentissement de l'état du malade sur la famille.

(1:03:50 - 1:04:12)

Donc, la prise en charge de la famille aussi, ça fait partie. Sur le plan spirituel, chez nous, la plupart du temps, la majorité, ce sont des musulmans. Ça n'empêche qu'il y a d'autres religions.

(1:04:14 - 1:04:42)

Normalement, de ce côté, on a peu de problèmes. Mais il y a des malades qui peuvent être en ce qu'on appelle une détresse psychologique. Ça veut dire que quand on lui annonce la maladie grave, quand on lui annonce qu'on soit palliatif et qu'il n'y a rien à faire pour lui, il y a ce qu'on appelle une détresse spirituelle ou l'éclatement de l'identité spirituelle.

(1:04:43 - 1:11:32)

Pourquoi moi? D'accord? Pourquoi moi? Ou parfois il y a soit une régression ou la complètement parfois qui le jargon populaire que ça veut dire c'est ses principes et son identité d'accord? Sinon il y a euh d'autres catégories il y a ce qu'on appelle un approfondissement de sa spiritualité ça veut dire quand il a un et c'est c'est la plupart des marocains donc euh dès qu'ils ont une maladie grave ça comment dirais-je? Il euh il sudérise à cent quatre-vingt d'accord? Euh par exemple qu'est-ce que euh et ainsi de suite. Donc ce qu'on appelle approfondissement soit éclatement tout à l'heure ou l'approfondissement de sa spiritualité. En conclusion donc euh j'ai pas trouvé de conclusion euh plus explicite que ça.

Donc pour les soins palliatifs c'est pas de faire diriger. Donc les soins palliatifs c'est accompagner quelqu'un ce n'est pas le précédé lui indiquer la route lui imposer à ni ténéraire ni même connaître la direction qu'elle va prendre c'est marcher à ses côtés en le laissant libre de choisir son euh son chemin et le rythme de son pas donc pour les soins palliatifs on fait pas pas diriger on n'impose pas mais on marche à côté de malade et on lui laisse le libre choix de marcher avec son rythme avec ses décisions avec ses objectifs donc c'est notre conclusion. Est-ce que vous avez des questions? Les questions? Ouais.

À domicile. Euh l'équipe l'équipe mobile peut se déplacer mais euh normalement à domicile c'est à la prise en charge de la femme donc euh je crois qu'au il y a au moins la moitié de la salle où ils connaissent des gens qui ont pris en charge à domicile par exemple les les sujets âgés qui font des des AVC il y a on les prend en charge la plupart du temps s'il y a pas de de thérapeutique la plupart du temps ils sont pris à domicile par les par les membres de la famille j'avais euh c'est pas un membre de la famille mais un un père d'un ami qui euh qui lui ont dédié une chambre à la maison ils ont loué un un lit hospitalier et euh quand même la famille ils ont un peu les moyens donc ils ont recruté une infirmière la la journée jusqu'à quinze heures, seize heures et après c'est les c'est ces filles et ces garçons qui qui euh à tort d'oral ils ils font la garde à partir de à partir de seize heures, dix-sept heures jusqu'à le lendemain où l'infirmière revient à à à huit heures du matin par exemple ce malade il avait un une tumeur viscale avec une insuffisance rénale stade stade de dialyse et à certains moments il est il n'y a plus rien à faire avec après il est il est devenu dément donc euh c'est la c'est la c'est la famille qui le qui le prend en charge la la pathologie la plus courante qu'on peut connaître c'est la c'est les malades qui font des des AVC aussi donc euh l'AVC il est constitué donc il n'est ni trombolisé ni euh de de technique radiointerventionnelle pour euh enlever le thrombus donc euh il est hémiplégique il a phasique donc la plupart du temps c'est la famille qui le prend en charge s'ils ont les moyens c'est la le nursing l'alimentation la le traitement et soit qu'elle s'améliore un petit peu il peut se déplacer sinon il reste à l'été jusqu'à ce qu'il décède ou les les vieux pas mal de de de membres de la famille qui euh dans le qui vit dans le dans le grand âge et qui sont pris en charge chez eux mais normalement la la prise en charge pour le système de santé soit l'équipe soit l'équipe mobile qui vient pour donner consultation pour changer un traitement éventuellement ou pour euh donner

l'indication hospitalisée soit en unité soit à l'hôpital ou envoyer l'envoyer aux urgences mais euh
sinon c'est à la prise en charge de la famille d'autres questions